



שיחה חדשה +

פרקי ההרצאה

01 פתיחה

02 המציאות בשטח

03 הפרדוקס של המצלמות

04 מה השתנה בטכנולוגיה

05 כל מצלמה היא שיחה

06 שיחה עם המצלמות

07 משימות והתראות

08 הבנה ללא גבולות

09 ציר הזמן של אירוע

10 תרחישים במרחב הרפואי

11 פרטיות ואתיקה

12 האדם במרכז

13 הטמעה בפועל

14 סיכום ושאלות

≈ 04 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"אני לא כאן כדי למכור לכם מערכת. אני כאן כדי להסביר מה השתנה — ולמה זה חשוב דווקא לכם."

- הצג את עצמך ואת הרקע שלך (עד 2 דקות).
- פתח בסיפור אישי קצר מביקור במרפאה או במלר"ד — רגע של מתח שכולם מכירים.
- הדגש מפורשות: זו הרצאת תוכן על טכנולוגיה ויישומים, לא מצגת מכירה.
- עבור על ארבעת החלקים והבטח שעה אחת בלי באזוורדס.

על מה נדבר בשעה הקרובה?

GHOST // LECTURE · HEALTHCARE SAFETY



המצלמות במרפאה רואות הכול. השאלה היא מי מקשיב להן בזמן.

הרצאת תוכן על מניעת אלימות במוסדות רפואיים: מה השתנה בטכנולוגיה של הבנת וידאו, איך מצלמות הופכות משחזור-בדיעבד לכלי מניעה בזמן אמת, ומה זה דורש מארגון בריאות — בלי להחליף אף מצלמה.

חלק 2 · הטכנולוגיה

הבנת סצנות ויזואליות בשפה טבעית — ושינוי הממשק שמגיע איתה.

חלק 1 · המציאות והפער

אלימות במערכת הבריאות, ולמה המצלמות של היום לא מונעות אותה.

חלק 4 · אתיקה והטמעה

פרטיות מטופלים, האדם שבמרכז, ומה נדרש כדי שזה יעבוד.

חלק 3 · היישומים

ציר הזמן של אירוע אלים, חלון המניעה, ותרחישים מהמרחב הרפואי.



שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 06 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"מי שיושב כאן באולם לא צריך שאקריא לו סטטיסטיקות. אתם חיים את זה."

• פתח בהצבעה: "מי כאן חווה אלימות מילולית בעבודה בשנה האחרונה?" — תן לתוצאה לדבר.

• לפני הכנס: עדכן את הנתונים מהדוח השנתי העדכני של משרד הבריאות וציין מקור.

• הדגש את תופעת תת-הדיווח — המספרים הרשמיים הם רצפה, לא תקרה.

• אם מזכירים אירועים קשים מהעבר — בזהירות וברגישות, בלי שמות ובלי פרטים מזהים.

כמה גדולה באמת בעיית האלימות במערכת הבריאות?

אלימות נגד צוותים רפואיים היא לא אירוע חריג. היא שגרה יומיומית.

בכל יום מדווחים במערכת הבריאות בישראל אירועי אלימות — במרפאות הקהילה, בבתי המרקחת, במוקדי הקבלה ובמחלקות לרפואה דחופה. הצוותים שבחזית — אחיות ואחים, מזכירות רפואיות, רוקחים ומאבטחים — סופגים את רובם.

תת-דיווח

חלק ניכר מהאירועים כלל אינו מדווח

מילולי ← פיזי

רוב האירועים הפיזיים מתחילים בהסלמה מילולית

דלפק ומלר"ד

מוקדי הסיכון המרכזיים — נקודות ההמתנה והחיכוך

כל יום

אירועי אלימות מדווחים במרפאות ובבתי החולים

• המחיר האנושי

שחיקה, פחד, נטישת מקצועות הסיעוד והקבלה — עוד לפני שדיברנו על פציעות.

• המחיר הארגוני

ימי היעדרות, תחלופת עובדים, אבטחה מתוגברת, ופגיעה ברצף הטיפול.

שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 05 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

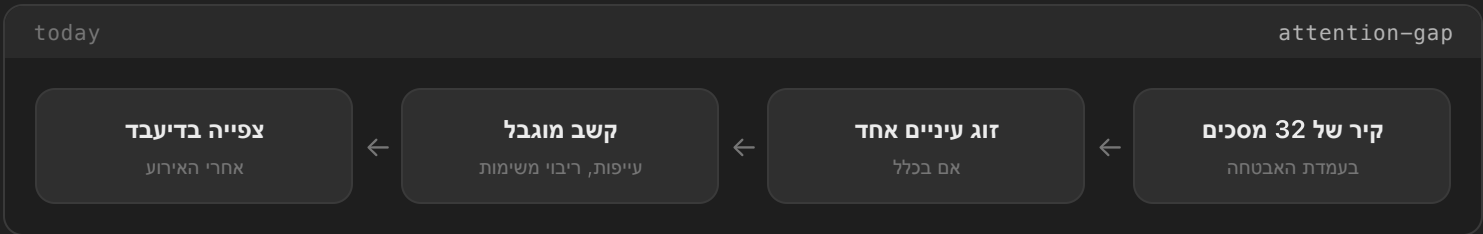
"ההקלטה מספרת מה קרה. מניעה דורשת להבין מה קורה — עכשיו."

- שאל את הקהל: מתי בפעם האחרונה משהו אצלכם "תפס" אירוע במצלמה בזמן אמת, ולא בדיעבד?
- הסבר את פער הקשב: המצלמות התרבו, אבל זוג העיניים שמולן נשאר אחד.
- סגור את החלק הראשון של ההרצאה במשפט המפתח שלמעלה — והשהה שנייה לפני המעבר לטכנולוגיה.

אם בכל מרפאה יש מצלמות — למה הן לא מונעות כלום?

המצלמה של היום היא עד ראייה. לא שומר סף.

כמעט כל מתקן רפואי מכוסה במצלמות. ובכל זאת — האירועים קורים מול העדשה, והמערכת לומדת עליהם רק אחרי שהם הסתיימו. הבעיה היא לא בעיניים. הבעיה היא בקשב.



- ההקלטה היא ראייתית, לא מונעת
היא מצוינת לחקירה ולתביעה — ולא שווה דבר ברגע שבו ההסלמה מתרחשת.

- אף אדם לא צופה בעשרות מסכים
מחקרי קשב מראים ירידה חדה ביכולת לזהות אירוע כבר אחרי דקות ספורות של צפייה במסכים מרובים.



שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...



שיחה חדשה +

פרקי ההרצאה

01 פתיחה

02 המציאות בשטח

03 הפרדוקס של המצלמות

04 מה השתנה בטכנולוגיה

05 כל מצלמה היא שיחה

06 שיחה עם המצלמות

07 משימות והתראות

08 הבנה ללא גבולות

09 ציר הזמן של אירוע

10 תרחישים במרחב הרפואי

11 פרטיות ואתיקה

12 האדם במרכז

13 הטמעה בפועל

14 סיכום ושאלות

≈ 06 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"ההבדל הוא כמו ההבדל בין גלאי עשן — לבין אדם שנכנס לחדר ומריח שמשהו נשרף."

• זה השקף הטכנולוגי המרכזי — דבר לאט וברור, הקהל אינו טכנולוגי.

• הסבר את ההבדל בין "כלל קבוע שמופעל" לבין "הבנה של מצב" עם דוגמה יומיומית.

• הדגש: אין רשימת יכולות סגורה ואין אימון — זה מה ששובר את התקרה של הדור הקודם.

• הימנע ממונחים טכניים. אם נשאלת על "איך זה עובד בפנים" — הפנה לשיחה אחרי ההרצאה.

מה בעצם השתנה, שמאפשר היום משהו אחר?

מודלים שמבינים תמונה כמו אדם — ומדברים איתנו בשפה שלנו.



בשנים האחרונות נולד דור חדש של מודלים שמחברים ראייה ושפה. הם לא מסמנים ריבועים סביב עצמים מתוך רשימה סגורה — הם מבינים סצנה שלמה: מי נמצא ביחס למה, מה מונח איפה, מה חריג בהקשר הזה. ומכיוון שהם מבינים שפה, אפשר פשוט לכתוב להם מה חשוב לנו.

שפה טבעית

מגדירים מה חשוב במשפט בעברית. בלי כללים, בלי תכנות, בלי הגדרות מסובכות.

הבנת סצנה, לא תיוג

המערכת מתארת מצב והקשר — כמו אדם חכם שמסתכל על המסך — ולא רשימת עצמים.

על המצלמות הקיימות

שכבת הבנה מעל התשתית שכבר מותקנת. אף מצלמה לא מוחלפת.

ללא אימון וללא איסוף דאטה

אין צורך ללמד את המערכת מראש. כל מה שאפשר לתאר במילים — אפשר לבקש.



שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 04 MIN

SPEAKER // GUIDE

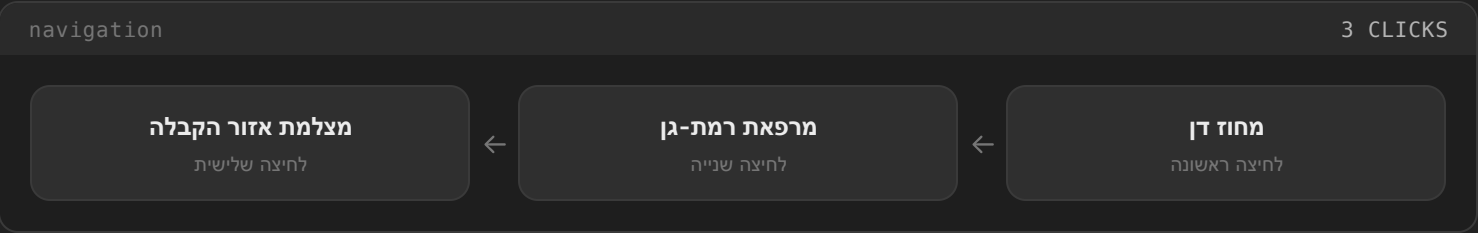
SAY THIS

- "תחשבו על המצלמות שלכם כמו על אנשי קשר. לכל מצלמה יש שיחה. לכל אזור יש קבוצה."
- הדגש: זה קודם כל שינוי ממשק — עוד לפני שדיברנו על בינה מלאכותית.
 - עבור על שלוש הלחיצות שעל המסך אחת-אחת, באצבע.
 - שאלה רטורית לקהל: כמה לחיצות נדרשות היום אצלכם כדי להגיע למצלמה ספציפית במרפאה ספציפית?

איך נראית עבודה מול מאות מצלמות — בלי קיר מסכים?

במקום קיר מסכים — רשימת שיחות. כמו וואטסאפ.

לפני שמדברים על בינה — מדברים על ממשק. כל מצלמה היא צ'אט. מצלמות מתארגנות בקבוצות — לפי מרפאה, מחוז או תפקיד. גם בארגון עם מאות מצלמות בעשרות מתקנים, מגיעים לכל נקודה בשלוש לחיצות:



שלוש לחיצות — כדי לראות, לשאול ולהגדיר משימות לכל מצלמה או אזור בארגון. הממשק שכולם כבר מכירים מהטלפון, מוחל על עולם שתקוע בממשקי שנות התשעים.

שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 04 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"התשובה הזו לא נכתבה מראש. אף אחד לא הגדיר 'עגלת תינוק' או 'ארגזי קרטון'. המערכת פשוט הסתכלה ותיארה."

- הקרא את השאלה והתשובה הראשונה בקול, מילה במילה — זה הרגע שממחיש הכי הרבה.
- הדגש את רמת הפירוט: מיקום, חפצים, יחסים בין דברים — לא תיוג יבש.
- הדוגמה השנייה מראה שזה לא רק ביטחון — גם בטיחות ותפעול באותו כלי.

מה בכלל שואלים מצלמה?

שואלים בעברית. ומקבלים תשובה של מי שבאמת מסתכל.

08:42

live-session

מה קורה עכשיו באזור ההמתנה של מרפאת הילדים?

באזור ההמתנה כתשעה ממתנינים. מול דלפק הקבלה עומדים שלושה אנשים צמודים לאשנב, אחד מהם רוכן מעל הדלפק ומסמכים פזורים עליו. עגלת תינוק חוסמת חלקית את המעבר לחדר האחיות. שאר הממתנינים יושבים במקומם.

האם יציאת החירום במסדרון הדרומי פנויה?

לא. עגלת ציוד ועליה ארגזי קרטון חוסמת כשני שלישים מרוחב הדלת. שלט היציאה מואר ותקין.

שימו לב לתשובות: לא "זוהה אירוע" ולא קוד שגיאה — תיאור של סצנה והקשר, ברמת פירוט של אדם שעומד מול המסך ומסתכל בעצמו.

שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...



שיחה חדשה +

פרקי ההרצאה

01 פתיחה

02 המציאות בשטח

03 הפרדוקס של המצלמות

04 מה השתנה בטכנולוגיה

05 כל מצלמה היא שיחה

06 שיחה עם המצלמות

07 משימות והתראות

08 הבנה ללא גבולות

09 ציר הזמן של אירוע

10 תרחישים במרחב הרפואי

11 פרטיות ואתיקה

12 האדם במרכז

13 הטמעה בפועל

14 סיכום ושאלות

≈ 05 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"ההבדל בין שאלה להתראה עומדת הוא ההבדל בין לבדוק לפעמים — לבין לדעת תמיד."

- הסבר את ההבדל בין שאילתה חד-פעמית (השקף הקודם) למשימה עומדת (השקף הזה).
- הקרא את דוגמת הניטור הרציף — היא לב יישום מניעת האלימות, נחזור אליה בעוד שני שקפים.
- הדגש: ההגדרה נכתבת במשפט אחד בעברית. מי שיודע לכתוב הודעת וואטסאפ — יודע להגדיר משימה.

ואם אף אחד לא שואל באותו רגע — מי שם לב?

מגדירים פעם אחת מה חשוב — והמערכת בודקת בשבילכם, כל הזמן.



השאלות החד-פעמיות הן רק ההתחלה. הכוח האמיתי הוא במשימות עומדות — הוראות בשפה חופשית שהמערכת מבצעת באופן קבוע:

- בדיקה מתוזמנת

"כל בוקר ב-06:30 — ודא שמסדרון המלר"ד פנוי ושאף יציאת חירום אינה חסומה בצידוד או באלונקות."

- ניטור רציף

"התרע כשמצטברת מול דלפק הקבלה התקהלות צפופה של יותר מחמישה ממתינים הנדחקים אל האשנב."

- בדיקה מותנית

"אחרי שעות הקבלה — בדוק שדלת חדר התרופות סגורה ושלא נשאר ציוד על עמדת האחיות."

- תיעוד מסודר

כל בדיקה וכל התראה נרשמות: מה נבדק, מה נמצא, מתי, ומי טיפל. זיכרון ארגוני שנבנה מעצמו.



שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 03 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"גם אנחנו לא יודעים מראש מה תרצו לבדוק — ולא צריכים לדעת. הגבול היחיד הוא הדמיון של מי שמגדיר."

• שקף קצר ונושם — תן לקהל רגע לעכל לפני המעבר ליישום המרכזי.

• אמור את משפט המפתח שבמסגרת, מילה במילה.

• אפשר לשאול את הקהל: מה הייתם רוצים שמישהו יבדוק עבורכם כל בוקר במרפאה?

איפה אפשר לראות את רשימת הדברים שהמערכת יודעת לבדוק?

אין רשימה. כל מה שאפשר לתאר במילים — אפשר לבדוק.

וזה היתרון המהותי על כל הדור הקודם: אין קטלוג יכולות, אין "אירועים נתמכים", ואין צורך לבקש פיתוח חדש לכל תרחיש. כמה דוגמאות מהשטח הרפואי — שאף אחת מהן לא הוגדרה מראש:

"בדוק אם נשארה אלונקה עם ציוד רפואי במסדרון בסוף המשמרת"

"ודא שדלת חדר התרופות נסגרה אחרי כל פתיחה"

"בדוק אם רצפת הכניסה רטובה ואין לידה שלט אזהרה"

"התרע אם מטף הכיבוי הוסר מעמדת הקיר ליד הכניסה"

גם אנחנו לא יודעים מראש מה תרצו לבדוק — ולא צריכים לדעת.

ברגע שהמערכת צופה במצלמות שלכם, אפשר להגדיר כל דבר שחשוב לכם. הגבול היחיד הוא הדמיון.



שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

+ שיחה חדשה

פרקי ההרצאה

01 פתיחה

02 המציאות בשטח

03 הפרדוקס של המצלמות

04 מה השתנה בטכנולוגיה

05 כל מצלמה היא שיחה

06 שיחה עם המצלמות

07 משימות והתראות

08 הבנה ללא גבולות

09 ציר הזמן של אירוע

10 תרחישים במרחב הרפואי

11 פרטיות ואתיקה

12 האדם במרכז

13 הטמעה בפועל

14 סיכום ושאלות

≈ 06 MIN

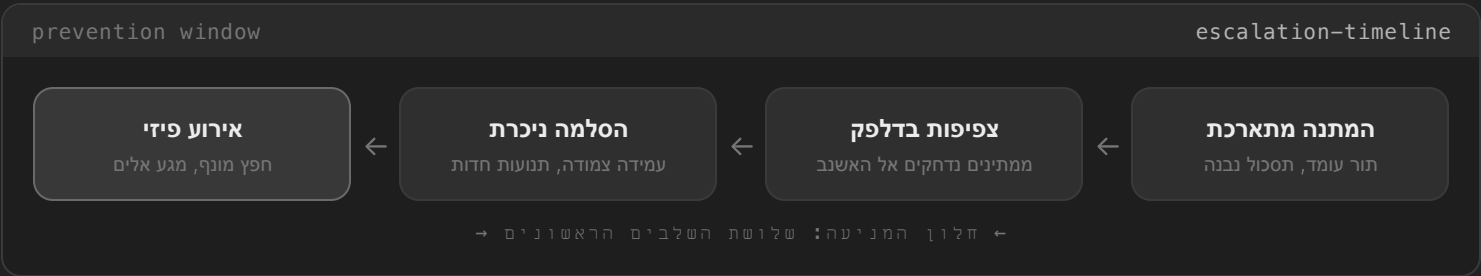
SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

- "כל מה שקורה משמאל לשלב האחרון — המצלמה רואה. השאלה היא רק אם מישהו יודע על זה בזמן."
- זהו לב ההרצאה — קח את הזמן. עבור על הציר שלב-שלב, באצבע, מימין לשמאל.
 - חבר כל שלב לחוויה מוכרת: כולם ראו תור תקוע, כולם ראו את הרגע שבו מישהו מתחיל להרים קול.
 - הדגש: ההתראה מגיעה לאדם — מאבטח, אח אחראי — וההתערבות היא אנושית: נוכחות, הרגעה, תגבור.
 - קשר לפרוטוקולי ההסלמה וההדרכות שכבר קיימים בכללית — הטכנולוגיה מזינה אותם, לא מחליפה אותם.

איפה בדיוק נמצא חלון המניעה?

אלימות כמעט אף פעם לא מתחילה במכה. היא מתחילה בסימנים.



כל השלבים המוקדמים גלויים למצלמה — אבל בלתי נראים למערכת שרק מקליטה. כשמשימה עומדת מזהה צפיפות חריגה מול הדלפק או הסלמה ניכרת באזור ההמתנה, אדם מקבל התראה לפני השלב האחרון — וצוות יכול להגיע, להרגיע, לתגבר או להפריד. זו כל התורה: להזיז את נקודת הידיעה אחורה בזמן.

+ שיחה חדשה

פרקי ההרצאה

01 פתיחה

02 המציאות בשטח

03 הפרדוקס של המצלמות

04 מה השתנה בטכנולוגיה

05 כל מצלמה היא שיחה

06 שיחה עם המצלמות

07 משימות והתראות

08 הבנה ללא גבולות

09 ציר הזמן של אירוע

10 תרחישים במרחב הרפואי

11 פרטיות ואתיקה

12 האדם במרכז

13 הטמעה בפועל

14 סיכום ושאלות

שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...



שיחה חדשה +

פרקי ההרצאה

01 פתיחה

02 המציאות בשטח

03 הפרדוקס של המצלמות

04 מה השתנה בטכנולוגיה

05 כל מצלמה היא שיחה

06 שיחה עם המצלמות

07 משימות והתראות

08 הבנה ללא גבולות

09 ציר הזמן של אירוע

10 תרחישים במרחב הרפואי

11 פרטיות ואתיקה

12 האדם במרכז

13 הטמעה בפועל

14 סיכום ושאלות

≈ 05 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"שימו לב שאף תרחיש כאן הוא לא 'יש מישהו באזור'. כל תרחיש הוא סצנה — עם הקשר, חפצים ומשמעות מבצעית."

- בחר שניים-שלושה תרחישים והרחב עליהם בסיפור קצר — אל תקריא את כל הרשימה.
- הדגש את הרוחב: אלימות, בטיחות, תפעול וחירום — מערכת אחת, שפה אחת.
- תרגיל קצר עם הקהל: בקש מהם להציע תרחיש משלהם, ונסח אותו יחד כמשפט משימה.

איך זה נראה בפועל — במרפאה, בבית מרקחת, במלר"ד?

משימות אמיתיות, בשפה שבה הן נכתבות. ביטחון, בטיחות, תפעול וחירום — באותו כלי.



- **התראה: כיסא מתכת מונף באוויר מעל דלפק הקבלה**
כשניירות ומסמכים מפוזרים על הרצפה לידו — הסלמה בעיצומה, כל שנייה קובעת.

- **התראה: התקהלות צפופה מול אשנב האחות התורנית**
יותר מחמישה ממתינים נדחקים אל האשנב כשדלת הזכוכית מוחזקת פתוחה — השלב שלפני ההסלמה.

- **בדיקה: עגלת החייאה חוסמת את יציאת החירום במסדרון המלר"ד**
מפגע בטיחות שגם מקשה על צוות להגיע במהירות לאירוע אלים.

- **בדיקה: דלת המחלקה נותרה פתוחה לרווחה אחרי שעות הביקור**
נקודת כניסה לא מבוקרת למחלקה רגישה — יולדות, ילדים, גריאטריה.

- **חירום: אדם שרוע על רצפת חדר ההמתנה ליד עמדת המים**
כוס פלסטיק הפוכה לידו — אירוע רפואי באזור שאף איש צוות לא רואה כרגע.

- **בטיחות: מטף כיבוי שהוסר מהקיר מוטל על הרצפה ליד עמדת השמירה**
גם חפץ שעלול לשמש לתקיפה, וגם ציוד חירום שאינו במקומו.



שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 05 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"ההבדל המהותי הוא בין 'לדעת מי' לבין 'להבין מה'. מניעת אלימות דורשת להבין מה — לא לדעת מי."

- אל תחכה שישאלו — פתח את נושא הפרטיות יזום. זה בונה אמינות מיידית.
- הסבר את ההבחנה: תיאור מצב ('התקהלות') לעומת זיהוי אדם ('פלוני נמצא כאן').
- הדגש את חובת השקיפות מול ועדי עובדים ומטופלים — מנקודת מבט אתית, לא רק משפטית.
- אם יש בקהל יועצים משפטיים או ממוני פרטיות — הזמן אותם לשיחה בסוף.

ומה עם הפרטיות של המטופלים ושל העובדים?

מרחב רפואי מחייב רף אחר. הפרטיות חייבת להיות חלק מהארכיטקטורה — לא תוספת.

זו השאלה הראשונה שכל ארגון בריאות צריך לשאול, ובצדק. העקרונות שצריך לדרוש מכל מערכת הבנת וידאו במרחב רפואי:

תיאור סצנות — לא זיהוי זהויות

המערכת מתארת מצבים ("התקהלות מול הדלפק"), לא קובעת מי האנשים. ללא זיהוי פנים וללא מעקב אחר אדם ספציפי.

שמירת מינימום

תובנות מובנות במקום אגירת וידאו גולמי; מדיניות מחיקה מוגדרת מראש.

עיבוד בסביבה מבודדת

תמיכה בפריסה מקומית ובסביבות מנותקות — הווידאו לא חייב לעזוב את הארגון.

בקרת גישה ותיעוד מלא

הרשאות לפי תפקיד, ותיעוד של כל שאלה וכל צפייה — מי, מה ומתי.

• שקיפות מול העובדים והמטופלים

שילוט ברור, שיתוף נציגות העובדים, ומדיניות כתובה — תנאי הכרחי לאמון, לא המלצה.

שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 03 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"המטרה היא לא להחליף אף אחד. המטרה היא שאף אחות לא תהיה לבד מול הסלמה — בלי שמישהו יודע."

- שקף קצר שעונה על החשש הכי נפוץ בקהל — גם אם לא נשאל בקול.
- פנה ישירות לאנשי הצוות באולם: זה כלי בשבילכם, לא מערכת פיקוח עליכם.
- אפשר לשלב סיפור על אירוע שבו דקה אחת של התרעה מוקדמת הייתה משנה הכול.

אז המערכת מחליפה את המאבטח?

לא. היא נותנת לו עיניים. ההחלטה נשארת אנושית — תמיד.

- **ההתראה מגיעה לאדם**

מאבטח, אח אחראי, מנהל משמרת — אדם מקבל את ההתראה, רואה את התמונה, ומחליט.

- **שיקול הדעת נשאר בידי הצוות**

להתקרב, להרגיע, לתגבר, להזעיק — ההתערבות היא אנושית ומקצועית. הטכנולוגיה רק מקצרת את הדרך אליה.

- **כלי לצוות — לא מעליו**

המטרה היא שאחות בעמדת קבלה תרגיש פחות לבד מול תור עוין. לא עוד מערכת שמפקחת עליה.

הטכנולוגיה מקצרת את הזמן שבין "משהו קורה" ל"מישהו יודע".

כל מה שקורה אחרי — נשאר בדיוק כמו שצריך: בידיים של אנשי המקצוע.

שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 04 MIN

SPEAKER // GUIDE

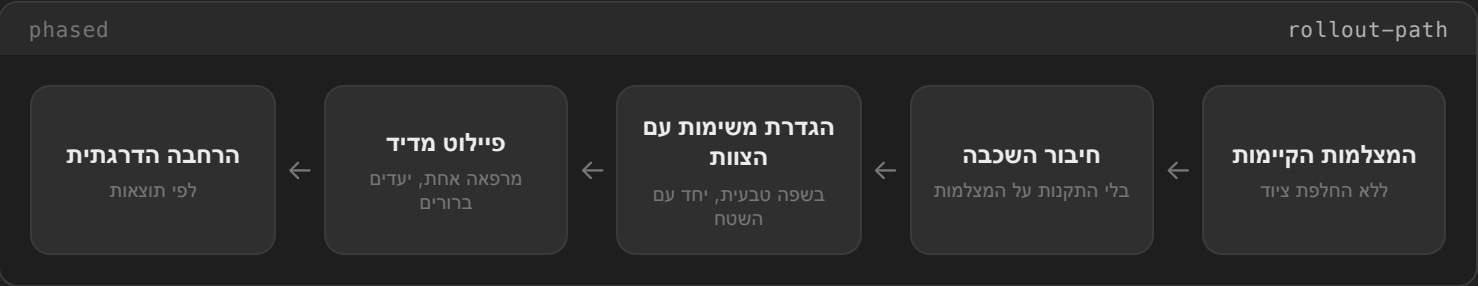
SAY THIS

"השאלה הנכונה היא לא 'כמה מצלמות צריך לקנות' — אלא 'מה אנחנו רוצים לדעת, ומי צריך לדעת את זה'."

- הדגש: אין החלפת תשתית ואין התקנות על המצלמות — זו הסרת החסם הגדול ביותר.
- המלץ על פיילוט קטן ומדיד במרפאה אחת עם מדדים מוגדרים מראש.
- חזור על עקרון השקיפות: שיתוף ועד העובדים וממונה הפרטיות מהיום הראשון.

מה נדרש כדי שזה יעבוד אצלנו בפועל?

לא פרויקט תשתית. שכבת הבנה מעל מה שכבר קיים.



• מה מודדים בפיילוט

זמן מהתחלת הסלמה ועד הגעת צוות, מספר התערבויות מוקדמות, אירועים שנמנעו, ותחושת הביטחון של הצוות.

• את מי מערבים מהיום הראשון

ביטחון, סיעוד, ועד העובדים, ממונה פרטיות, ומנהל המרפאה — הצלחת הטמעה היא ארגונית לפני שהיא טכנולוגית.



שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...

≈ 04 MIN

SPEAKER // GUIDE

SAY THIS

"אם תצאו מכאן עם משפט אחד — שיהיה זה: מניעה מתחילה ברגע שבו מישהו יודע בזמן."

- סכם את ארבע הנקודות בקצב — משפט לכל אחת, בלי לפתוח מחדש.
- פתח לשאלות. אם הקהל שקט, שאל בעצמך: "מה הייתם רוצים לדעת כל בוקר על המרפאה שלכם?"
- שאלות דיון רזרביות: איפה אצלכם נקודת החינוך הכי קשה? מי אצלכם צריך לקבל את ההתראה הראשונה?
- סיים בתודה לצוותים שבחזית — הם הסיבה שההרצאה הזו קיימת.

אז מה לוקחים הביתה מהשעה הזו?

המצלמות כבר שם. ההבדל הוא היכולת להבין אותן — בזמן.

• 1 הבעיה היא קשב, לא כיסוי

האירועים קורים מול עדשות שאף אחד לא מסוגל לצפות בהן ברציפות. ההקלטה מתעדת — היא לא מונעת.

• 2 הטכנולוגיה השתנתה מהיסוד

הבנת סצנות בשפה טבעית, בלי רשימות סגורות ובלי אימון — מעל המצלמות הקיימות.

• 3 חלון המניעה אמיתי

הסימנים המוקדמים גלויים למצלמה. כשאדם מקבל התראה בזמן — יש לו דקות, לא שניות.

• 4 האדם נשאר במרכז

פרטיות בארכיטקטורה, שקיפות מול הצוות, והחלטה אנושית — תמיד.

שאלות?

אפשר גם אחרי ההרצאה — אשמח להמשיך את השיחה.

שאל את Ghost על מה שקורה עכשיו במרפאה...